

药物渗透占静脉穿刺的 11%~58%^[4]。静脉输液致疼痛时传统护理方法^[5]主要以 50% 硫酸镁溶液湿敷,改善局部血液循环,以减轻疼痛,但大部分病人疗效欠佳。

中医理论认为,静脉输入引起的疼痛是输液过程中的穿刺伤及高渗药物刺激静脉壁致局部脉络血行不畅,血瘀滞阻,不通则痛;气血不畅,凝聚肌肤,津液输布受阻则胀痛;瘀血内蕴,蕴久化热,则局部发热;脉络损伤,血溢肌肤,或血热内蕴则局部发红。其机制在于血瘀气滞,毒结凝滞于血脉,致使局部脉络气血运行不畅所致^[6]。五马膏主要成分为五味藤、桂枝、乳香、没药等。此药剂具有温通经络、活血化瘀、祛瘀止痛等功效。局部持续热敷可扩张血管,增加血液循环,改善内皮细胞的功能,同时可以防止甘露醇微粒沉积在血管内膜。本研究结果显示,实验组用五马膏热敷后,疼痛发生率明显低于对照组($P<0.01$)。提示,五马膏热敷局部能减轻甘露醇静脉输入所致疼痛,从而降低静脉炎发生率,减轻病人痛苦。本护理方法具有廉价、高效、方便、无副反应等特点,值得临床推广。

参考文献:

- [1] 林桂荣,刘京凤,王恒珍,等. 20%甘露醇致静脉损伤的防护[J]. 中华护理杂志,1998,33(2):71-72.
- [2] 刘驰,李雅杰. 甘露醇致静脉炎的原因分析及护理干预[J]. 河南外科学杂志,2005,11(2):101.
- [3] 吴晓燕,岳继峨,霍海英,等. 甘露醇致静脉损伤的机制与护理[J]. 中国寄生虫病防治杂志,2004,17(4):256-257.
- [4] 朱志红,杨丽. 静脉渗漏性损伤[J]. 实用护理杂志,1994,10(12):20.
- [5] 杨文琴,赵丽华. 化疗性静脉炎防治研究进展[J]. 全科护理,2009,7(7B):1862-1864.
- [6] 茹海凤,闵筱兰. 祛瘀消肿精外敷预防浅静脉留置针引起静脉炎的效果观察及护理[J]. 中国中医急症,2008,17(5):725.

作者简介 李美杏(1967—),女,护士长,主管护师,大专,工作单位:530012,广西壮族自治区骨伤医院;黄花新工作单位:530012,广西壮族自治区骨伤医院。

(收稿日期:2009-08-20;修回日期:2010-04-22)

(本文编辑 李亚琴)

护理干预对阿尔茨海默病 病人生活质量的影响

Influence of nursing intervention on quality
of life of patients with Alzheimer disease

孙晓晖,苏海丹,李雪洁

Sun Xiaohui, Su Haidan, Li Xuejie

(Nursing College of Guangdong Medical College, Guangdong 524023 China)

摘要:[目的]探讨护理干预对早、中期阿尔茨海默病(AD)病人生活质量的影响。[方法]将 36 例早、中期 AD 病人随机分为试验组和对照组。对照组进行常规出院指导,出院后不施加任何干预;试验组在常规出院指导基础上进行为期 1 年的护理干预,包括对病人及家属进行 AD 疾病知识及护理知识的宣教、家居安全护理指导、心理护理及情感支持、康复训练指导及遵医行为指导等。两组干预前后分别采用简明健康状况量表(SF-36)测评病人的生活质量。[结果]干预后试验组病人 SF-36 综合评分为 570.1 分士 141.9 分,显著高于干预前($P<0.01$),亦显著高于对照组($P<0.01$)。[结论]护理干预能有效地提高早、中期 AD 病人的生活质量。

关键词:阿尔茨海默病;护理干预;生活质量

中图分类号:R473.74 **文献标识码:**C **doi:**10.3969/j.issn.1009-6493.2010.13.019 **文章编号:**1009-6493(2010)5A-1167-03

阿尔茨海默病又称老年性痴呆(AD),是一种原因不明的中枢神经系统原发性退行性疾病,多起病于老年期,潜隐起病,病程缓慢且不可逆,主要临床症状为痴呆综合征^[1]。目前我国 60 岁以上的老人已达 1.2 亿人,大约有 500 万老年性痴呆病人。国内外研究提示,随着年龄的增长,老年性痴呆的发病率将逐步增高,80 岁以上老年人痴呆的发病率可达 80%。老年性痴呆正成为一个严重影响老人及其家庭生活质量的疾病,老年性痴呆的防治是每一个家庭必须面对的问题。目前对 AD 尚缺乏特异的治疗手段,而护理对延缓病人病情发展、提高生活质量尤为重要^[2]。为探讨护理干预对早、中期 AD 病人生活质量的影响,

2007 年 10 月—2008 年 10 月对 38 例早、中期 AD 病人实行护理干预,效果满意。现报告如下。

1 对象与方法

1.1 对象 选择本院老年病区就诊住院的 AD 病人。诊断标准:根据简明智能精神状态量表(mini-mental status examination, MMSE)和长谷川智力量表^[3]中的 AD 诊断标准,通过 Hachinski 量表进行鉴别诊断为老年性痴呆,并根据临床痴呆评定量表(CDR)评定为早期和中期的 AD 病人。符合上述条件者 38 例,随机分为试验组和对照组各 19 例。两组一般资料比较,差异无统计学意义($P>0.05$),有可比性,见表 1。

表 1 两组病人一般资料比较

组别	例数	性别(例)		年龄 岁	受教育年限 年	学历(例)			
		男	女			文盲	小学	初中	高中及以上
对照组	19	10	9	73.2±4.2	6.1±4.9	3	3	10	3
试验组	19	9	10	74.1±3.6	6.3±3.7	2	3	11	3

1.2 方法

1.2.1 干预方法 对照组进行常规出院指导,出院后不施加任何干预。试验组除常规出院指导外,护士每周电话访问 1 次;每 2 周安排 1 次免费门诊护理咨询;每 4 周进行 1 次家访;每 3 个月举办 AD 病人及家属座谈会 1 次。干预时间为 1 年。干预内容包括:①对病人家属进行 AD 疾病及护理知识的宣教,并根据 AD 病人及家属常见的护理问题编写“老年性痴呆病人健康须知”。②家居安全护理指导。针对 AD 病人常见的误吸、误服、跌倒、失走、热伤等居家安全问题对病人和家属进行指导,以减轻居家安全问题的发生率。③心理护理及情感支持。运用支持性心理护理技术,如倾听、解释、保证、指导和建议、疏泄、鼓励、促进自助。具体内容主要是耐心倾听病人和家属提出的问题,了解病人的个性特点,有针对性地对病人及其家属进行心理护理,同时根据病人的心理特征,采用安慰、鼓励、暗示等方法予以开导;调动家庭照顾者的真诚,给予病人充分的关注和理解,使病人感受到家庭的温暖,减轻其心理压力;鼓励病人参加一些力所能及的家庭、社会活动,如种花、养鱼、画画等以分散病人的注意力和避免不良情绪产生,使其感受到生活的乐趣和自身的存在价值。④康复训练指导。日常生活能力训练,如做饭、进食、穿衣、洗刷、沐浴、购物等日常生活能力训练,先叙述后模拟,尽量帮助其维持一种固定的生活习惯;认知训练,通过回忆和生活回顾、调动兴趣爱好、支持小组的训练方式^[4];记忆训练,对于有

严重记忆障碍的老人,可运用环境影响其行为^[5],如保持恒定的常规环境,多次的重复性刺激,采用背诵、帮助分析、联系概念、联系自身、听说读写并用、编故事、记日记、看图片等方法训练记忆;思维训练,通过排列数字、物品分类、数字计算等,训练病人综合分析、判断、推理和计算能力;逻辑思维与表达能力训练,如对病人密切相关问题的提问,并进行简单的数字计算;体能训练,根据病人的身体状况,选择合适的体能训练,如公园散步、做老人体操、跳舞等,活动量循序渐进,以无不适为度。⑤遵医行为指导,指导和督促病人按医嘱定时、定量以正确的方式服药,告知用药的注意事项,保证用药安全。

1.2.2 评定方法 采用简明健康状况量表(SF-36)对病人进行评定,分别在干预前和干预 1 年后各评定 1 次。SF-36 第 2 版由美国波士顿健康研究所研制,是一种多目的、简明的健康调查量表,包括 36 个问题 8 个维度,具体包括生理功能(PF)、生理职能(RP)、躯体疼痛(BP)、总体健康(GH)、活力(VT)、社会功能(SF)、心理职能(MH)、情感职能(RE),对身心健康进行综合测量。将每个维度初得分转化为终得分,8 个维度评分之和为综合评分,每个维度的标准总分为 100 分,分数越高提示健康状况越好,即生活质量越高。

1.2.3 统计学方法 采用 SPSS 10.0 软件对数据进行 *t* 检验。

2 结果(见表 2)

表 2 两组干预前后 SF-36 评分比较										分
组别	时间	生理功能	生理职能	躯体疼痛	活力	社会功能	情感职能	心理职能	总体健康	综合评分
对照组	干预前	53.8±19.2	32.6±7.4	85.9±14.7	57.8±22.7	65.4±33.6	40.8±15.0	66.4±19.8	47.4±18.6	450.1±151.0
	干预后	46.2±18.3 ¹⁾	19.2±8.9 ¹⁾	74.8±19.8 ¹⁾	55.0±23.9	65.2±24.1	33.9±13.0	67.2±19.2	43.8±19.2	405.1±146.4
试验组	干预前	51.6±22.8	33.1±8.2	84.0±15.2	58.1±17.1	63.3±25.1	42.6±13.1	67.5±16.8	47.9±14.1	448.1±132.4
	干预后	61.3±32.5 ¹⁾²⁾	51.0±8.0 ¹⁾²⁾	90.3±17.8 ¹⁾²⁾	72.0±17.6 ¹⁾²⁾	81.2±24.7 ¹⁾²⁾	70.4±17.9 ¹⁾²⁾	81.2±10.5 ¹⁾²⁾	62.7±12.9 ¹⁾²⁾	570.1±141.9 ¹⁾²⁾

与本组干预前比较,1) *P*<0.01;与对照组干预后比较,2) *P*<0.01。

3 讨论

3.1 护理干预有效地促进了 AD 病人身心健康 AD 是一种慢性渐进性退化性痴呆,以缓慢进展的智力减退为特征,最终导致无力进行日常生活和人格的持续变化,若得不到悉心护理,病人的生存期限会明显缩短^[2]。对于老年性痴呆病人,护理人员不应只重视疾病本身,还应重视老年人的生活功能是否健康。大多数病人及家属 AD 知识缺乏^[6],使得病人在家庭中难以获得正规的、全面的康复护理。护士在护理干预过程中进行 AD 疾病及护理知识指导,并指导家属对病人进行智能、体能等康复训练^[7]。本研究结果显示,经过 1 年的家庭护理干预后,试验组病人的生理功能、生理职能、心理职能和综合评分显著高于干预前和对照组(*P*<0.01),有效地改善了病人的躯体健康和心理健康。

3.2 护理干预促进了 AD 病人社会健康 社会健康主要包括角色、家庭、环境等方面的健康。在护理干预中注重发挥家庭和社会的作用,培养病人的自理能力,鼓励病人做力所能及的事,

使病人体会到生存的价值;并通过健康教育讲座,提高社会对 AD 的认识,促进病人、家属之间的交流,通过家庭、社会的努力,为病人营造一个积极、安全、富有情感色彩的环境。表 2 结果显示,经过 1 年的护理干预后,试验组病人的社会功能、情感职能评分均高于干预前和对照组(*P*<0.01)。说明病人接受护理干预后社会功能有所改善。

3.3 护理干预加强了护患沟通,建立了良好的护患关系 有调查发现,75.4%的照顾者缺乏老年痴呆病人的护理知识与技能,93.8%的照顾者希望从医务人员处获得健康知识^[6]。因此,在护理干预中我们定期召开病人及家属座谈会,解答家属的疑问,通过家属间的经验交流来缓解精神压力,教会照顾者放松自己的技巧,有效地调整了家庭照顾者的心态,从而提高病人及家属的遵医行为;还针对最常见的误吸、误服、跌倒、失走、热伤等问题实施护理干预,强调家属进行环境管理、物品管理和外出管理的重要性,结果家居安全问题的发生率降低,表明有效地家庭护理干预能减少 AD 病人居家意外的发生。

综上所述,及早对 AD 病人进行护理干预,可改善病人的健康状况,提高病人的生活质量。

参考文献:

- [1] 孙建萍,朱丹,李彩福,等.老年护理[M].第2版.北京:人民卫生出版社,2005,124—131.
- [2] 张月华,卢少萍,徐永能,等.家庭护理干预对老年性痴呆患者生活质量的影响[J].护理学杂志,2005,20(1):3—5.
- [3] 周宝玉,曾幼鲁,王国相,等.81例痴呆患者的临床疗效分析[J].中华精神科杂志,1994,28(3):143.
- [4] 王玲,杨萃,张亚荣,等.4例老年性痴呆患者认知训练方法的探讨[J].中华护理杂志,2005,40(11):848—850.

- [5] 朱英.老年痴呆的康复治疗与护理[J].中国误诊学杂志,2005,5(16):3149—3150.
- [6] 张月华,卢少萍,符霞,等.老年性痴呆患者家属健康教育需求的研究[J].护理学杂志,2003,18(7):542.
- [7] 吴婉玲,黄永青,周凤婵.老年痴呆病人家属的家庭护理知识教育[J].家庭护士,2008,6(3C):839—840.

作者简介 孙晓晖(1977—),女,湖南人,讲师,本科,从事老年护理研究,工作单位:524023,广东医学院护理学院;苏海丹、李雪洁工作单位:524023,广东医学院护理学院。

(收稿日期:2009—07—24;修回日期:2010—04—20)

(本文编辑 李亚琴)

护理干预对非酒精性脂肪肝病人健康行为影响的临床研究¹⁾

Clinical research on influence of nursing intervention on health behaviors of patients with nonalcoholic fatty liver

王晓曦,王萍,韩纲

Wang Xiaoxi, Wang Ping, Han Gang(Fourth People's Hospital of Datong City Shanxi Province, Shanxi 037008 China)

摘要:[目的]研究护理干预对非酒精性脂肪肝病人健康行为的影响。[方法]124例非酒精性脂肪肝病人在常规保肝治疗的情况下,针对性地制订护理干预方案并给予实施,于初次发现、干预2年后评价实施干预前后的健康相关行为和治疗效果。[结果]干预前后病人的健康行为和体重指数、腰围、B型超声检查结果、肝功能、血脂水平均存在差异($P<0.01$)。[结论]对非酒精性脂肪肝病人进行护理干预,可以提高病人对疾病的认知水平,有助于其改变不良行为,建立健康行为,提高治疗效果。

关键词:非酒精性脂肪肝;健康行为;护理干预

中图分类号:R473.5 文献标识码:C doi:10.3969/j.issn.1009-6493.2010.13.020 文章编号:1009-6493(2010)5A-1169-02

脂肪肝是一种脂代谢紊乱性疾病,是由于各种原因引起的,肝细胞内脂肪过多堆积而形成的,与单纯性肥胖、饮酒、营养失调、糖尿病等有关^[1]。近年来,随着人们生活水平的不断提高和饮食习惯与结构的变化,不良生活方式的影响以及预防保健措施的滞后,使脂肪肝的发病率持续上升。健康行为的建立对阻止脂肪肝病人的病情发展、治疗脂肪肝起着重要作用。本研究通过对124例单纯性脂肪肝病人采取护理干预措施,分析护理干预对非酒精性脂肪肝病人健康相关行为的影响,为健康教育的实施提供参考。

1 对象与方法

1.1 对象 本组124例均为我院体检中心在2005年1月—2007年12月发现的非酒精性脂肪肝病人,其诊断均符合中华医学会肝脏病学分会脂肪肝和酒精性肝病学会于2002年10月修订的非酒精性脂肪肝诊断标准^[2]。其中男83例,女41例,年龄21岁~69岁(35岁±5岁)。所有病例均为初发病例,且临床症状轻,运动干预均在病人自觉症状消失后开始实施。

1.2 方法

1.2.1 建立病人健康档案并专人管理 向病人说明建立健康

档案的目的和意义,取得病人知情同意后建立健康档案,记录年龄、性别、职业、身高、体重、腰围、臀围、饮食、生活习惯、运动、吸烟以及饮酒的基本情况,并记录血脂、肝功能、B型超声检查结果。

1.2.2 实施护理干预

1.2.2.1 实施健康教育 由经过培训的护士对病人进行多种形式的健康教育,如组织病人及家属听取专题讲座,重点讲解脂肪肝相关知识及其危险因素,如肥胖、不合理饮食、不良生活方式、饮酒等,发放健康教育处方。必要时对其反复教育,并要求家属参与,共同对病人进行健康干预。向病人及家属讲解完全遵医嘱^[3],即指能够完全遵从医嘱,合理用药,完全依从治疗建议的行为。

1.2.2.2 进行饮食干预 告知病人高脂肪、高热量饮食是脂肪肝的重要成因。将病人喜爱及本地习惯食用的食物中每100g所含脂肪、热量、蛋白质量印成资料发放给病人,对病人每天所吃的油、盐、糖、主食、副食的质和量进行科学指导,每人每天脂肪的摄入量控制在25g以下,盐量控制在5g以下;尽量少吃糖;饮食宜清淡、低脂、低胆固醇;多吃新鲜蔬菜、水果、瘦肉、鱼、

1) 为山西省大同市科技基金立项课题,编号:61—2—95。